

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΧΚΑ

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Αναστολείς Μετατρεπτικού Ενζύμου | 5. Ανταγωνιστές Αλδοστερόνης |
| 2. Αποκλειστές Υποδοχέων Αγγειοτασίνης II | 6. Β - Αναστολείς |
| 3. Διουρητικά (θειαζιδικά και άλλα) | 7. Δακτυλίτιδα |
| 4. Συνδυασμός ΑΜΕΑ ή ΑΥΑ με διουρητικό | 8. Αναστολείς SGLT-2 |

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΤΙΚΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ (α -ΜΕΑ)

Η χορήγηση των α -ΜΕΑ είναι ιδιαίτερος ωφέλιμη στη θεραπεία της ΧΚΑ, ανεξαρτήτως εάν συνυπάρχει αρτηριακή υπέρταση (ΑΥ) ή όχι. Και αυτό προκύπτει διότι:

- Προκαλούν αγγειοδιαστολή και μειώνουν το καρδιακό προ- και μεταφορτίο.
- Μειώνουν τις συστηματικές αγγειακές αντιστάσεις.
- Μειώνουν την σκλήρυνση της αορτής.
- Βελτιώνουν το ενεργειακό ισοζύγιο του μυοκαρδίου.

Η χρήση τους ενδείκνυται για πρόληψη και θεραπεία σε όλους τους ασθενείς με ΧΚΑ με κλάσμα εξώθησης (LVEF) < 40%, ακόμη και στους ασυμπτωματικούς. Επίσης, σε ασθενείς με ΧΚΑ ανεξαρτήτως κλάσματος εξώθησης με ιστορικό εμφράγματος του μυοκαρδίου.

Οι α -ΜΕΑ έχουν επίσης ένδειξη για τις εξής κατηγορίες ασθενών:

- Ασθενείς υπερτασικοί, με ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου.
- Ασθενείς με ΑΥ και ιστορικό ΣΔ τύπου 2.
- Ασθενείς με ΑΥ και χρόνια νεφρική νόσο ($eGFR < 60 \text{ ml/min/1.73 m}^2$).
- Ασθενείς με ΑΥ, ηλικίας > 65 ετών.

Αρχικώς, χορηγείται μικρή δόση α -ΜΕΑ και εφόσον γίνει καλά ανεκτή τότε επιχειρείται διπλασιασμός της δόσεως, κάθε 2 εβδομάδες, μέχρι την επιθυμητή ή τη μέγιστη δόση.

Η μακρά διάρκεια δράσης, ορισμένων εξ αυτών, θεωρείται πλεονεκτική και ζητούμενη, επειδή επιτρέπει τη χορήγησή τους μια φορά την ημέρα (qd), αλλά αποτελεί και ιδιότητα που θεωρείται ιδιαίτερος ευεργετική σε ασθενείς με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια.

ΟΥΣΙΑ	ΣΚΕΥΑΣΜΑ	Ημερήσια δόση	$t_{\max}$	Χρόνος Ημιζωής
Βεναζεπρίλη	<i>Cibacen</i>	5-20 mg	1,5 h	10 h
Εναλαπρίλη	<i>Renitec / Analept</i>	10-20 mg	6-12 h	11 h
Ζοφενοπρίλη	<i>Zofepril / Zopranol</i>	7,5-30 mg	2-7 h	6 h
Καπτοπρίλη	<i>Normolose</i>	50-200 mg	3-5 h	3 h
Κιναπρίλη	<i>Accupron</i>	20-40 mg	1,5-3 h	26 h
Λισινοπρίλη	<i>Zestril / Z-Bec</i>	10-20 mg	1-2 h	24 h
Περινδοπρίλη	<i>Coversyl</i>	4-8 mg	0,5-1 h	9 h
Ραμιπρίλη	<i>Triatec / Piramil</i>	5-10 mg	0,5-2 h	15 h
Σιλαξαπρίλη	<i>Vascase</i>	2,5-5 mg	1 h	40 h
Τραντολαπρίλη	<i>Testolan</i>	0,5-4 mg	6 h	10 h
Φοσινοπρίλη	<i>Monopril</i>	20-40 mg	3 h	12 h

Για να αποφευχθεί η υπερκαλιαιμία, θα πρέπει πριν αρχίσει η χορήγηση ενός α -ΜΕΑ να διακοπεί η χορήγηση διουρητικών προστατευτικών της απώλειας καλίου, καθώς και των σκευασμάτων υποκατάστασης καλίου (Sopa-K). Η έναρξη χορήγησης α -ΜΕΑ σε ασθενείς με ΧΚΑ που ήδη λαμβάνουν υψηλές δόσεις διουρητικών της αγκύλης (*Φουροσεμίδα 80 mg ή Τορασεμίδα 10 mg ημερησίως*) είναι πιθανό να προκαλέσει σοβαρή υπόταση.